프로락틴 상승 시 진료 프로토콜

프로락틴(Prolactin)은 모유 분비와 생리 주기에 관여하는 뇌하수체 호르몬입니다. 한 번 높게 나왔다고 바로 큰 병을 의미하지는 않아, 검사 조건과 흔한 원인을 차분히 확인합니다.

진료실에서 보는 4단계 흐름

단계	진료실에서 하는 일
STEP 01 **증상·약 확인**	월경 변화, 유즙 분비, 두통·시야 증상과 복용약을 먼저 확인합니다.
STEP 02 **안정 상태 재검**	가능하면 오전, 도착 후 휴식한 상태에서 다시 측정해 일시 상승을 걸러냅니다.
STEP 03 **흔한 원인 배제**	임신 가능성, 갑상선 기능, 신장·간 기능, 약물 영향을 함께 봅니다.
STEP 04 **지속 상승 평가**	반복 상승이나 증상이 있으면 뇌하수체 MRI(자기공명영상), 내분비 의뢰를 검토합니다.

재검 전 준비와 함께 확인할 원인



긴장·수면 부족·격한 운동·임신/수유처럼 일시 상승 요인을 먼저 확인합니다.

재검 조건	확인할 원인
오전 채혈을 우선 권장합니다.	**임신 가능성** 또는 최근 수유 여부
도착 후 10~20분 안정하고 채혈합니다.	**갑상선기능저하**, 신장·간 기능 이상
전날 과격한 운동, 음주, 밤샘은 피합니다.	항정신병약, 항구토제, 일부 항우울제, 진통제
검사 전 식사·공복 조건은 진료실 안내에 맞춥니다.	다낭성난소증후군(PCOS), 월경 불규칙
검사 당일 복용약·영양제를 접수 시 알려주세요.	반복 상승 시 뇌하수체 병변 가능성

바로 알려야 할 증상과 가져오면 좋은 정보

진료실에 바로 알려주세요

시야가 좁아짐 또는 물체가 겹쳐 보임

새롭고 심한 두통, 구토가 동반되는 두통

임신·수유와 무관한 유즙 분비

무월경, 월경 주기 변화, 난임 상담 중인 경우

진료 때 준비하면 좋습니다

복용 중인 약 이름, 용량, 시작 시점

최근 3개월 생리 주기와 마지막 생리 시작일

임신 가능성, 수유 여부, 피임약·호르몬제 사용

최근 스트레스, 수면 부족, 운동, 이전 검사 결과 · 급격한 체중 감소·제한적 식사·과도한 운동

오늘 기억할 점

프로락틴 상승은 **재검으로 확인**하고, 약물·임신·갑상선·신장 기능처럼 흔한 원인을 먼저 살핍니다. 반복해서 높거나 증상이 동반되면 영상검사나 내분비 진료로 이어질 수 있습니다. 월경 불규칙은 프로락틴 한 수치만으로 판단하지 않고 다낭성난소증후군·시상하부성 무월경·난소기능 저하도 구분합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — Endocrine Society Hyperprolactinemia CPG · Endotext Prolactinoma Management

아산 28회 연수강좌 — 월경이 불규칙한 환자, 무엇을 확인해야 하나?(이사라)

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 진단과 치료는 증상, 복용약, 임신 여부, 재검 결과를 함께 보고 결정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/hyperprolactinemia-protocol/